MX-CONNECT

PROPOSITION INDICATIVE
DE PHASE PILOTE · NOV. 2026

MX-CONNECT

Phase pilote : 18 mois pour faire la preuve

Dans un district de santé, montrer comment des mutuelles outillées protègent mieux les ménages et orientent les populations vers la Couverture Santé Universelle.



Ministère de la Santé Publique

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique

ARAILD

Présenté par
ARAILD – Action pour la Recherche et l'Appui aux Initiatives Locales de Développement

+237 676 460 158
contact@araild.com
Yaoundé – Cameroun

RÉSUMÉ

Dix-huit mois, un district, une question : que gagnent les ménages quand mutuelles, CSU et formations sanitaires travaillent ensemble ?

18 mois
de cadrage, déploiement, exploitation et évaluation

1
district de santé, choisi avec le MINSANTE

3 à 5
mutuelles de santé pilotes (hypothèse)

5 à 8
formations sanitaires connectées (hypothèse)

CE QUE LE PILOTE DÉMONTRE

- Des mutuelles gérées en ligne, transparentes et contrôlables.
- Des droits mutualistes vérifiés en quelques secondes au guichet.
- Des ménages informés et orientés vers l'enrôlement CSU officiel.
- Des jeunes mobilisés comme relais communautaires.
- Des données agrégées utiles au pilotage, sans donnée médicale exposée.

CE QUE NOUS SOLLICITONS

- Une convention de partenariat et un comité de pilotage interministériel.
- Le choix conjoint du district et des mutuelles.
- Pour la CSU : un cadre d'accès et de vérification autorisé.
- L'appui à la mobilisation d'un financement de **≈ 55 millions FCFA** (estimation indicative).

PRINCIPE DIRECTEUR

La mutuelle protège selon ses garanties. La CSU couvre dans le cadre national. MX-CONNECT coordonne, sans jamais confondre les deux ni se substituer au dispositif officiel.

Toutes les quantités et tous les montants de ce document sont des hypothèses de travail, à arrêter avec le comité technique.

1.1 — POURQUOI UN PILOTE

Passer de la promesse à la preuve, à une échelle maîtrisée

72,2 %

Le constat

Les ménages paient encore directement l'essentiel de leurs soins ; moins de 5 % sont couverts par une assurance ou une mutuelle.

4,6 M

L'élan

La CSU a déjà enrôlé des millions de personnes ; elle a besoin de relais de proximité pour atteindre les autres.

1

L'outil

MX-CONNECT est en ligne. Il reste à l'éprouver sur le terrain, avec les administrations, avant toute extension.

1.2 — OBJECTIF GÉNÉRAL

Démontrer, dans un district de santé, qu'une plateforme numérique de coordination renforce la gestion des mutuelles de santé, sécurise les prises en charge et facilite l'orientation des populations vers la Couverture Santé Universelle, dans le respect strict du rôle de chaque acteur.

1.3 — OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

OS1 **Gestion mutualiste.** Numériser l'ensemble des adhérents, cotisations, garanties et comptes des mutuelles pilotes.

OS2 **Prise en charge.** Permettre aux formations sanitaires pilotes de vérifier les droits mutualistes et de tracer chaque prise en charge.

OS3 **Orientation CSU.** Informer, orienter et suivre les personnes non enrôlées vers le dispositif officiel, sous convention.

OS4 **Mobilisation.** Former et animer un réseau de jeunes ambassadeurs de la mutualité et de la CSU.

OS5 **Preuve.** Produire des données agrégées fiables et une évaluation indépendante pour éclairer la décision d'extension.

2.1 — CHOIX DU DISTRICT

Un district choisi pour apprendre vite et extrapoler juste

Mutuelles actives — au moins trois mutuelles de santé fonctionnelles, volontaires pour le pilote.

Mixité urbain / rural — pour tester l'outil dans des contextes de connectivité différents.

Réseau mobile — couverture suffisante dans les formations sanitaires retenues.

Points d'enrôlement CSU — présence d'au moins un point officiel accessible aux populations.

Engagement local — équipe cadre de district, communes et associations disponibles.

Accessibilité — pour un suivi de terrain régulier par l'équipe projet.

2.2 — COMPOSITION INDICATIVE

ÉLÉMENT	HYPOTHÈSE	REMARQUE
District de santé	1	Proposé par le MINSANTE ; critères ci-dessus
Mutuelles de santé pilotes	3 à 5	Volontaires, de tailles différentes
Formations sanitaires connectées	5 à 8	Conventionnées avec au moins une mutuelle pilote
Adhérents et ayants droit suivis	[__]	Selon les effectifs réels des mutuelles retenues
Jeunes ambassadeurs formés	40	Avec le MINJEC, le Conseil national de la jeunesse et l'ASCNPD
Gestionnaires et agents formés	≈ 75	Mutuelles, formations sanitaires, district

Inclusion. Le pilote vise en priorité les ménages à faibles revenus, les travailleurs de l'économie informelle et les personnes éloignées des formations sanitaires, sans jamais conditionner l'adhésion à une mutuelle à une démarche CSU, ni l'inverse.

3 — COMPOSANTES DU PILOTE

Cinq composantes, un même fil conducteur

COMPOSANTE A · OS1

Mutuelles numériques

- Paramétrage des mutuelles, garanties et réseaux de soins
- Reprise des adhérents et ayants droit
- Encaissements tracés, reçus, comptabilité SYSCOHADA

Livrable : mutuelles 100 % en ligne, états comptables produits

COMPOSANTE B · OS2

Guichets connectés

- Cartes mutualistes à QR signé
- Portail prestataire, lecture de carte, vérification journalisée
- Factures contrôlées, contrôle à quatre yeux

Livrable : FOSA pilotes équipées, prises en charge tracées

COMPOSANTE C · OS3

Orientation vers la CSU

- Information documentée des ménages
- Repérage volontaire, orientation, suivi
- Statut CSU distinct ; « déclaré » séparé de « confirmé »

Livrable : module développé et utilisé sous convention

COMPOSANTE D · OS4

Mobilisation communautaire

- Jeunes ambassadeurs formés et équipés
- Causeries, campagnes, invitations par WhatsApp
- Projets locaux visibles sur le réseau

Livrable : 40 ambassadeurs actifs, 12 campagnes

COMPOSANTE E · OS5

Données, conformité, évaluation

- Déclaration APDP, audit de sécurité
- Tableau de bord d'indicateurs agrégés
- Enquête de référence et évaluation externe

Livrable : rapport d'évaluation et recommandations

A, B et D : fonctions déjà disponibles. C : à développer et à activer seulement sous convention avec le MINSANTE.

3.6 — CE QUE VIVRA UN MÉNAGE PENDANT LE PILOTE

Le parcours de Mireille et de sa famille

Personnage fictif, à titre d'illustration : Mireille, 34 ans, commerçante, mère de trois enfants, n'a ni mutuelle ni enrôlement CSU.

01 — SEMAINE 1

Elle entend parler de la mutuelle

Un jeune ambassadeur l'informe lors d'une causerie au marché, et lui partage le lien de la mutuelle par WhatsApp.

02 — SEMAINE 2

Elle adhère, avec ses enfants

Le gestionnaire enregistre le ménage et les ayants droit ; elle règle son droit d'adhésion et reçoit un reçu. Sa carte mutualiste à QR lui est remise.

03 — MÊME JOUR

On lui propose, sans obligation, de vérifier sa situation CSU

Non enrôlée, elle accepte d'être orientée vers le point d'enrôlement officiel le plus proche. Son statut passe à « en cours de démarche ».

04 — MOIS 2

Son fils est soigné au centre de santé

L'agent lit la carte : droits mutualistes ouverts. La prise en charge est déclarée et tracée ; elle ne paie que sa part.

05 — MOIS 3

Son enrôlement CSU est confirmé par le dispositif officiel

Le statut devient « enrôlement confirmé ». Elle relève désormais des deux mécanismes, gérés séparément et coordonnés sans double facturation.

POUR LE MÉNAGE

Moins de dépenses imprévues, des droits clairs, une démarche CSU accompagnée.

POUR LE DISPOSITIF CSU

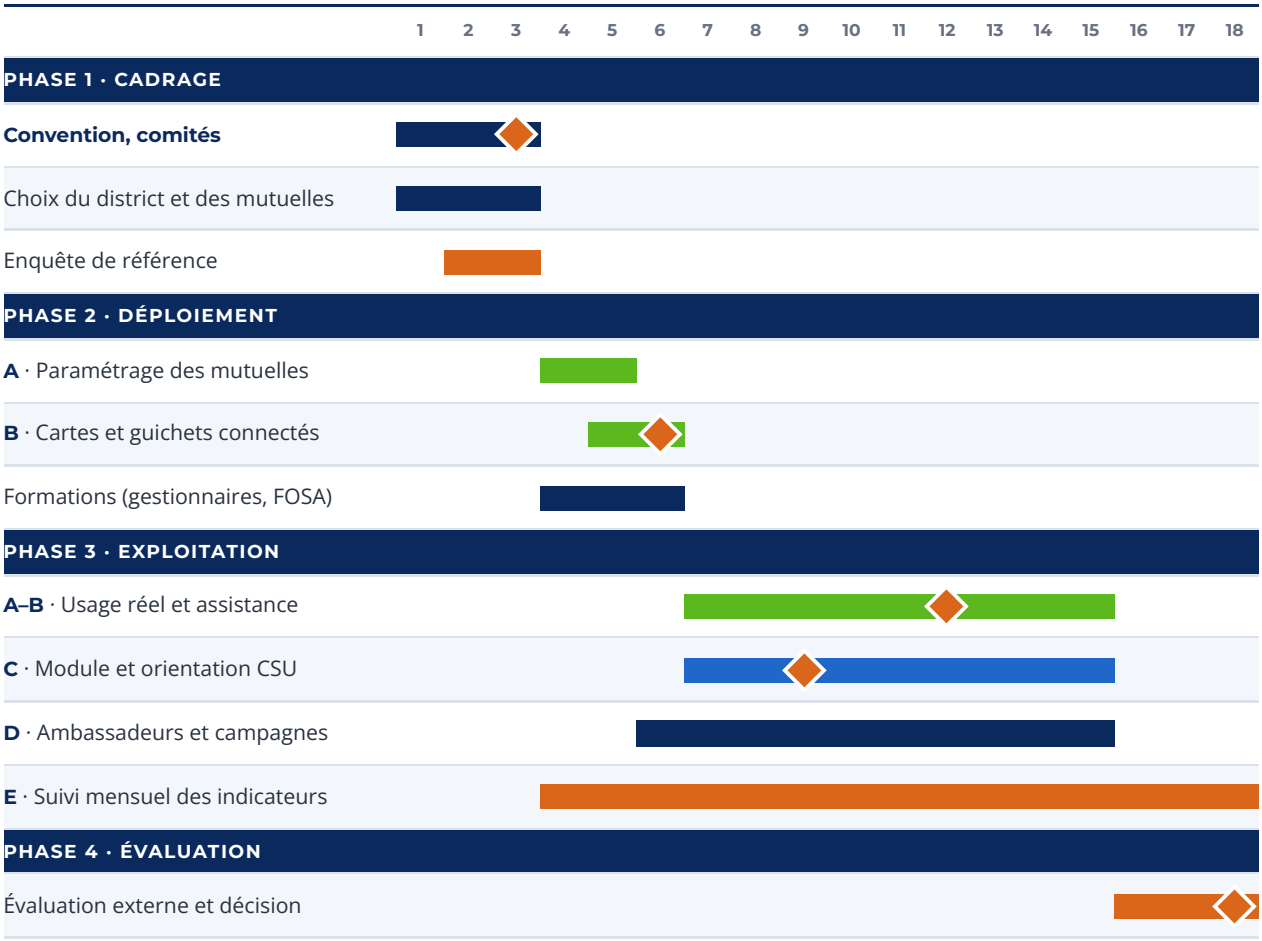
Une personne de plus orientée et enrôlée, suivie jusqu'à la confirmation.

POUR LE PILOTAGE

Des étapes comptées une à une, sans jamais compter une orientation comme un enrôlement.

4.1 — CHRONOGRAMME INDICATIF

Quatre phases, cinq jalons de décision



PHASE 1 · M1–M3

Cadrage

Convention, comités, choix du district, enquête de référence.

PHASE 2 · M4–M6

Déploiement

Paramétrage, formations, cartes, guichets connectés.

PHASE 3 · M7–M15

Exploitation

Usage réel, orientation CSU, mobilisation, suivi mensuel.

PHASE 4 · M16–M18

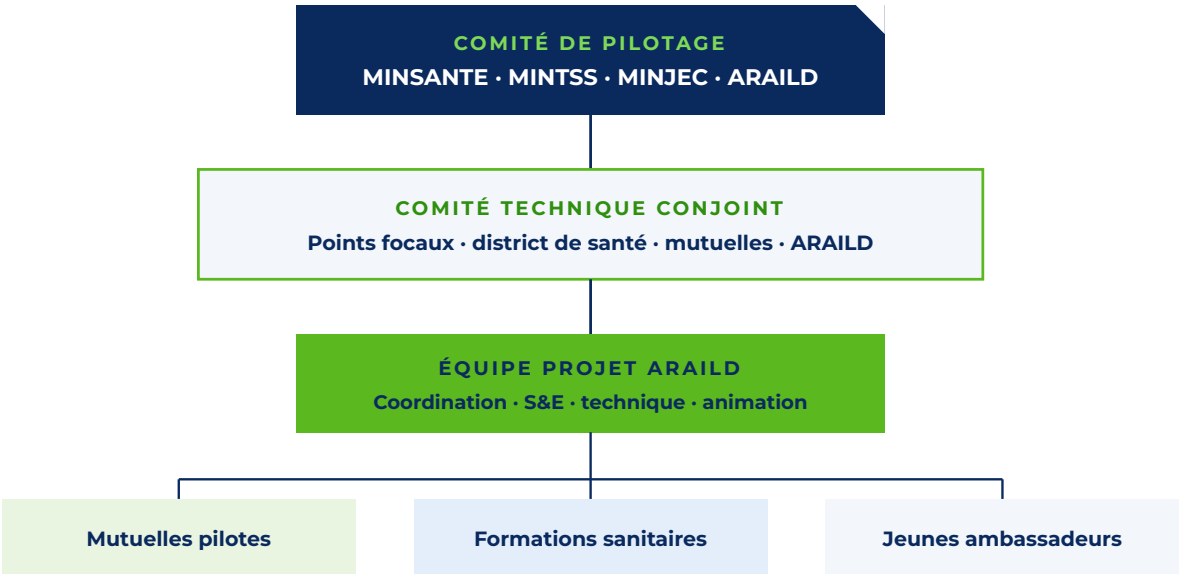
Évaluation

Évaluation externe, capitalisation, décision d'extension.

◆ Jalons : J1 convention signée et district retenu (M3) · J2 premières cartes et guichets actifs (M6) · J3 module CSU opérationnel si la convention le permet (M9) · J4 revue à mi-parcours (M12) · J5 évaluation finale et décision (M18).

4.2 — GOUVERNANCE DU PILOTE

Les ministères décident, le terrain exécute, l'évaluation tranche



INSTANCE	RYTHME	RÔLE
Comité de pilotage	Semestriel (3 réunions)	Orientations, validation des jalons, décision d'extension
Comité technique conjoint	Trimestriel (6 réunions)	Choix des sites, validation des indicateurs, suivi des risques
Équipe projet ARAILD	Continu	Déploiement, formation, assistance, rapports mensuels
Mutuelles et FOSA	Continu	Usage quotidien, remontée des difficultés, contrôle à quatre yeux
Évaluateur externe	M1–M3 et M16–M18	Situation de référence, évaluation finale indépendante

Fonds. MX-CONNECT ne détient jamais de fonds : les cotisations restent la propriété des mutuelles et transitent par leurs caisses et comptes. La plateforme trace les opérations, elle n'encaisse rien.

5 — CADRE DE RÉSULTATS INDICATIF

Ce qui sera mesuré, et comment

OBJ.	INDICATEUR	CIBLE	SOURCE	FRÉQUENCE
OS1	Mutuelles pilotes gérées entièrement en ligne	100 %	Plateforme	Trimestrielle
OS1	Adhérents et ayants droit enregistrés	[__]	Plateforme	Mensuelle
OS1	Taux de recouvrement des cotisations	[__] %	Plateforme	Mensuelle
OS1	Encaissements accompagnés d'un reçu	100 %	Plateforme	Mensuelle
OS2	FOSA pilotes réalisant des vérifications de droits	[__] / [__]	Journal des vérifications	Mensuelle
OS2	Prises en charge tracées de bout en bout	[__]	Plateforme	Mensuelle
OS3	Membres sensibilisés à la CSU	[__]	Registre d'information	Mensuelle
OS3	Personnes orientées vers l'enrôlement	[__]	Module CSU	Mensuelle
OS3	Taux de confirmation des enrôlements	[__] %	Dispositif officiel	Trimestrielle
OS3	Personnes couvertes par les deux mécanismes	[__]	Plateforme + dispositif	Trimestrielle
OS4	Jeunes ambassadeurs actifs	40	Réseau social	Trimestrielle
OS4	Campagnes de sensibilisation réalisées	12	Rapports d'activité	Trimestrielle
OS5	Satisfaction des ménages et des agents	[__] %	Évaluation externe	M3, M18
OS5	Incidents de sécurité ou de confidentialité	0	Journal d'audit	Continue

Règles de comptage. Une personne orientée n'est jamais comptée comme enrôlée ; seul le dispositif officiel ou une vérification autorisée confirme un enrôlement. Les cibles [__] seront fixées après l'enquête de référence. Aucune donnée médicale n'est utilisée dans les indicateurs.

6 — BUDGET INDICATIF SUR 18 MOIS

≈ 55 millions FCFA, dont 38 % pour les équipes de terrain



POSTE	HYPOTHÈSE DE CALCUL	FCFA
A · ÉQUIPE PROJET	**37,9 %**	**20 700 000**
Coordonnateur(trice) du pilote	18 mois × 450 000	**8 100 000**
Chargé(e) de suivi-évaluation et des données	18 mois × 300 000	**5 400 000**
Animateurs communautaires (4)	4 × 15 mois × 120 000	**7 200 000**
B · PLATEFORME ET CONFORMITÉ	**17,5 %**	**9 580 000**
Hébergement sécurisé, sauvegardes, supervision	18 mois × 60 000	**1 080 000**
Module « statut CSU » et interopérabilité (sous convention)	forfait	**6 000 000**
Audit de sécurité et conformité APDP	forfait	**2 500 000**
C · ÉQUIPEMENT ET CONNECTIVITÉ	**8,0 %**	**4 350 000**
Smartphones pour FOSA et mutuelles (lecture QR)	15 × 85 000	**1 275 000**
Forfaits de données mobiles	15 × 15 mois × 7 000	**1 575 000**
Impression de cartes mutualistes	3 000 × 500	**1 500 000**
D · FORMATION ET MOBILISATION	**11,1 %**	**6 050 000**
Formation des gestionnaires (mutuelles, FOSA)	3 sessions × 25 pers. × 2 j × 15 000	**2 250 000**
Formation des jeunes ambassadeurs	40 pers. × 2 j × 10 000	**800 000**
Campagnes de sensibilisation (CSU, mutualité)	12 × 250 000	**3 000 000**
E · GOUVERNANCE ET ÉVALUATION	**20,8 %**	**11 400 000**
Comités technique (6) et de pilotage (3)	6 × 150 000 + 3 × 300 000	**1 800 000**
Enquête de référence et évaluation finale (externe)	forfait	**6 000 000**
Déplacements et supervision de terrain	18 mois × 200 000	**3 600 000**
Imprévus	5 % du total	**2 604 000**
Total indicatif sur 18 mois		**54 684 000**

Montants estimatifs, toutes taxes comprises, à affiner avec le comité technique et selon les règles du bailleur. La plateforme existante est mise à disposition du pilote par l'ARAILD (contribution proposée, à confirmer). Sources de financement à mobiliser : budgets publics, partenaires techniques et financiers, contributions en nature.

7 — RISQUES ET MESURES D'ATTÉNUATION

Anticiper ce qui peut freiner le pilote

RISQUE	NIVEAU	MESURE D'ATTÉNUATION
Retard de la convention CSU	MOYEN	Les composantes A, B et D démarrent sans attendre ; la composante C se limite à l'information et à l'orientation jusqu'à la signature.
Confusion mutuelle / CSU	MOYEN	Messages validés par le MINSANTE, carte marquée « mutualiste », statuts séparés dans l'outil.
Faible adoption par les mutuelles	MOYEN	Mutuelles volontaires, accompagnement de proximité, assistance pendant tout le pilote.
Connectivité insuffisante	MOYEN	Application légère, lecture de carte par photo, forfaits de données, saisie différée.
Protection des données	FAIBLE	Déclaration APDP, audit de sécurité, données cloisonnées, double authentification, aucune donnée médicale dans le réseau.
Rotation du personnel des FOSA	MOYEN	Formations de rattrapage, guides courts, référents par établissement.
Fraude ou double facturation	FAIBLE	QR signé, vérification journalisée, contrôle à quatre yeux, règles de coordination.
Financement incomplet	MOYEN	Budget modulaire par composante ; démarrage possible avec A et B.

SUIVI DES RISQUES

L'équipe projet tient un registre des risques, mis à jour chaque mois. Il est examiné à chaque comité technique ; tout risque élevé est porté sans délai à l'attention du comité de pilotage.

8.1 — ENGAGEMENTS PROPOSÉS

Chacun apporte ce qu'il sait faire

ARAILD

- Mise à disposition de la plateforme et de son équipe
- Déploiement, formation, assistance, rapports
- Respect des principes : données cloisonnées, aucun fonds détenu

MINSANTE

- Choix du district, appui de l'équipe cadre
- Cadre d'accès CSU et validation des indicateurs
- Normes d'interopérabilité du PSNSN

MINTSS

- Appui à la structuration des mutuelles
- Liens avec la protection sociale et la CNPS
- Apports au cadre juridique de la mutualité

MINJEC

- Mobilisation des jeunes et des associations
- Reconnaissance du volontariat (ASCNPD)
- Appui aux campagnes de sensibilisation

8.2 — APRÈS LE PILOTE

Un modèle pensé pour durer et s'étendre

01

Viabilité

Un abonnement des mutuelles adapté à leur taille, à définir avec elles, pour couvrir l'exploitation.

02

Appropriation

Des gestionnaires et des référents formés, des guides, une assistance qui se réduit progressivement.

03

Extension

Selon l'évaluation : autres districts de la région, puis déploiement national aligné sur le PSNSN.

CE QUE LE PILOTE LAISSERA, QUELLE QUE SOIT LA DÉCISION FINALE

- Des mutuelles numérisées, aux comptes tenus en SYSCOHADA
- Des gestionnaires, agents et jeunes formés
- Une situation de référence documentée sur l'accès à la CSU
- Des recommandations évaluées pour la politique publique

MX-CONNECT

PROCHAINES ÉTAPES · 90 JOURS

Lancer le pilote en trois mois.

J + 15	Présentation de la proposition et démonstration en direct
J + 30	Désignation des points focaux et installation du comité technique
J + 60	Choix du district et des mutuelles ; budget et plan de financement arrêtés
J + 90	Signature de la convention et lancement officiel du pilote

PRÉSENTÉ PAR

ARAILD — Action pour la Recherche et l'Appui aux Initiatives Locales de Développement

CONTACT

+237 676 460 158
contact@araild.com
Yaoundé — Cameroun · m.araild.com